외국인의 비자 종류와 이주민 건강권, 보건소와 지역사회의 역할

주민, 보건소, 지역사회가 함께 읽는 근거기반 공공안내문

[한눈에 보는 핵심]
우리 사회에 정착하는 이주민이 늘어나면서, 이주민의 건강은 곧 지역사회 전체의 공중보건과 직결되고 있습니다. 이 안내문은 이주민들이 한국에 머무는 목적(비자)과 등록 상태를 쉽게 이해하고, 보건소와 지역 민간단체가 협력하여 의료 사각지대를 줄일 수 있도록 돕기 위해 공신력 있는 연구와 통계를 바탕으로 작성되었습니다. 이번에는 **「2024 이주민 영유아 건강권 실태조사」**의 주요 결과도 함께 반영해, 임산부·신생아·영유아 건강권의 사각지대를 보다 분명하게 보완했습니다.

1. 왜 이 문서를 다시 정리했는가? (자주 혼동하는 지점)

기존에 우리가 이주민에 대해 오해하거나 혼동하기 쉬웠던 몇 가지 사실을 바로잡기 위함입니다.

- **모든 합법 체류 외국인이 '등록외국인'은 아닙니다:** 합법적으로 입국했더라도, 보통 90일을 초과하여 장기 체류할 때 외국인등록을 해야 '등록이주민'이 됩니다.
- **F-3 비자는 '결혼이민 비자'가 아닙니다:** F-3는 전문인력, 유학생 등 다양한 체류자격 소지자의 배우자나 자녀에게 발급되는 **'동반가족 비자'**입니다. 결혼이민 비자는 F-6입니다.
- **G-1 비자는 특정 대상만을 위한 것이 아닙니다:** G-1은 매우 넓은 '기타' 성격의 체류자격입니다. 다만 본 문서에서는 건강취약계층의 맥락에서 자주 언급되는 '난민신청자'나 '인도적 사유 체류자'를 중심으로 설명합니다.
- **이주민은 단순히 노동력이 아닌 더불어 사는 우리 이웃입니다.:** 2015년 이후 한국에 오래 머무는 '정주형' 이주민의 규모가 크게 늘어, 현재는 취업 목적 이주민의 약 2배에 달합니다. 지역사회의 이웃으로 바라보아야 합니다.

2. 비자와 등록 여부, 아주 쉽게 이해하기

등록이주민은 보통 합법적인 체류자격을 가지고 한국에 입국한 뒤, 90일 이상 머물기 위해 출입국관서에 외국인등록 절차를 마친 분들을 말합니다. 우리가 흔히 아는 비자(E-9, F-6 등)를 가지고 생활하는 이웃입니다. **미등록이주민**은 체류기간이 지났거나 자격을 잃는 등 여러 사정으로 인해 현재 공식적인 등록 상태가 아닌 분들입니다. 신분상의 불안과 건강보험 부재로 병원에 가기 매우 힘든 상황에 처해 있습니다.

3. 생활 기준으로 다시 보는 이주민 유형

구분	대표 비자	쉽게 말하면	건강에서 주로 부딪히는 문제	현장에서 특히 볼 점
외국인 노동자	E-9, E-10, H-2	일하러 온 이주민	산재·직업병·감염병·정신건강	사업장 접근, 통역, 휴일검진
전문인력	E-1~E-7	전문직·기술직 종사자	가족적응, 아동 예방접종	가족동반 지원
동반가족	F-3	배우자·자녀로 함께 온 가족	아동건강, 예방접종, 정보 부족	학교·보육·접종 연계
결혼이민	F-6	한국인과 가정을 이룬 이주민	임신·출산·산후·양육 스트레스	모자보건, 정신건강, 폭력 연계
정주 이주민	F-2, F-4, F-5	오래 정착해 사는 이주민	만성질환·노인건강·돌봄	지역사회 통합관리
유학생	D-2, D-4	공부하러 온 청년 이주민	결핵·정신건강·고립	대학·기숙사 연계
취약 이주민	G-1, F-2-4	보호가 더 필요한 이주민	트라우마·응급·필수의료	인도적 접근, 상담 연계
미등록 이주민	없음	등록 상태가 아닌 이주민	의료회피·감염병·모자보건 사각지대	최소 접근, 조기개입

4. 비자군별 쉽게 설명

1) 일하러 온 사람 (E-9, E-10, H-2)

- **누구인지:** 농어업, 제조업, 건설업 등에서 근무하기 위해 온 비전문인력, 선원, 방문취업 동포입니다.
- **자주 생기는 문제:** 열악한 근로환경, 장시간 노동으로 인한 산재와 직업병, 단체생활로 인한 감염병 위험(예, 코로나 19 델타 유행시 외국인 선원 집단 감염)에 노출되기 쉽습니다.
- **보건소와 지역사회가 살펴볼 점: 언어 장벽 해소를 위한 통역 지원과 평일에 시간을 내기 힘든 이들을 위한 휴일·야간 검진 연계가 필요합니다.**

2) 전문직·기술직으로 온 사람 (E-1~E-7)

- **누구인지:** 교수, 원어민 강사, 연구원, IT 등 특정 활동 분야의 전문지식을 가진 분들입니다.
- **자주 생기는 문제:** 상대적으로 안정적이지만, 낯선 타국 생활의 스트레스나 가족 단위 이주 시 적응 문제가 발생할 수 있습니다.
- **보건소와 지역사회가 살펴볼 점: 주로 동반한 가족들의 지역사회 적응과 아동 예방접종 안내 등 가족 단위의 지원이 도움이 됩니다.**

3) 동반가족 (F-3)

- **누구인지:** 유학(D-2)이나 취업(E-1~E-7) 비자 등을 가진 이주민을 따라 함께 입국한 배우자나 미성년 자녀입니다.
- **자주 생기는 문제:** 본인은 취업이 엄격히 제한되는 경우가 많아 사회적으로 고립되기 쉽고, 보건의료 정보 접근성이 매우 떨어집니다.
- **보건소와 지역사회가 살펴볼 점: 자녀의 필수 예방접종 확인, 영유아 건강검진, 학교 및 보육 시설과의 건강 정보 연계가 필수적입니다.**

4) 결혼·가족 형성 (F-6)

- **누구인지:** 한국인과 혼인하여 가정을 이룬 결혼이민자입니다.
- **자주 생기는 문제:** 문화와 언어가 다른 상태에서 겪는 임신, 출산, 산후우울증, 양육 스트레스가 큰 부담으로 작용합니다.

- **보건소와 지역사회가 살펴볼 점: 촘촘한 모자보건 사업 연계, 가족 갈등이나 폭력 발생 시 신속한 보호 연계 및 정신건강 지원이 필요합니다.**

5) 오래 정착해 사는 사람 (F-2, F-4, F-5)

- **누구인지:** 거주(F-2), 재외동포(F-4), 영주권(F-5)을 가지고 지역사회에 뿌리내린 이주민입니다.
- **자주 생기는 문제:** 장기 거주하며 연령이 높아짐에 따라 당뇨, 고혈압 등 만성질환과 노인 건강 문제가 대두됩니다.
- **보건소와 지역사회가 살펴볼 점: 내국인과 동일한 수준의 만성질환 관리와 지역사회 노인 돌봄 통합 관리가 필요합니다.**

6) 공부하러 온 사람 (D-2, D-4)

- **누구인지:** 대학(원)에서 유학하거나 어학연수를 받는 청년 학생들입니다.
- **자주 생기는 문제:** 언어 문제와 고립감으로 인한 정신건강 문제, 기숙사 등 단체생활로 인한 결핵 감염 위험이 있습니다.
- **보건소와 지역사회가 살펴볼 점: 대학교나 기숙사와 연계한 결핵등 감염병 관리 및 청년 우울증 상담 연계가 중요합니다.**

7) 보호가 필요한 취약 이주민 (G-1, F-2-4)

- **누구인지:** 난민 신청, 질병 치료, 소송 등 다양한 사유로 기타(G-1) 자격으로 체류하거나, 난민인정을 받아 거주(F-2-4) 자격을 얻은 분들입니다.
- **자주 생기는 문제:** 본국의 핍박이나 도피 과정에서 얻은 트라우마가 깊고, 체류가 불안정하여 심리적·경제적 위기에 처하기 쉽습니다.
- **보건소와 지역사회가 살펴볼 점: 응급 및 필수의료에 대한 따뜻한 인도적 접근과 트라우마 치료를 위한 상담 연계가 절실합니다.**

8) 체류 자격이 없는 미등록 이주민

- **누구인지:** 비자 만료 등으로 현재 합법적인 등록 상태가 아닌 이주민입니다.
- **자주 생기는 문제:** 단속의 두려움과 건강보험 미적용으로 인한 막대한 병원비 때문에 의료 이용을 회피하여 병을 심각하게 키우는 경우가 많습니다.
- **보건소와 지역사회가 살펴볼 점: 감염병과 모자보건은 국적을 가리지 않으며 건강권은 인류가 가져야할 기본권에 해당함으로 , 지역사회 확산 방지를 위한 조기 개입과 최소한의 접근이 보장되어야 합니다.**

5. 이주민 건강이 왜 취약해지기 쉬운가?

연구에 따르면 이주민은 언어 차이로 인한 건강문해력 부족, 사회적 배제와 혐오, 열악한 주거와 근로환경, 건강보험 제도에서의 제한 등 복합적인 요인으로 건강이 취약해지기 쉽습니다.

*** 건강한 이주민 효과 (Healthy Migrant Effect)의 함정:**
이주 초기에는 상대적으로 젊고, 입국 전 건강확인 서류를 통과했기 때문에 선주민보다 건강해 보일 수 있습니다. 하지만 타국에서의 장기 체류, 고된 노동, 스트레스가 누적되면서 이 '건강 효과'는 쉽게 사라지고 오히려 급격히 건강이 악화될 수 있습니다.

아플 때 병원에 가지 못하는 이유 (조사 결과)

- 치료비 부담: **37.4%**
- 한국어를 잘 못해서: **24.4%**
- 시간이 없어서: **22.4%**
- 기타 (복잡한 절차, 가까운 병원 없음 등): **11.9%**
- 어느 병원을 가야 할지 몰라서: **3.9%**

이러한 공적 보건의료의 공백을 현재 상당 부분 이주민 전용 민간 진료소나 자원봉사 단체들이 힘겹게 메우고 있는 실정입니다.

영유아 건강권 실태조사가 보여준 추가 경고 신호 (2024)

- **미등록 아동의 빠른 증가:** 보고서에 따르면 10세 미만 장기체류 미등록 아동은 2018년 1,321명에서 2023년 5,161명으로 약 3.9배(290.7%) 늘었습니다.
- **낮은 건강 수준 인식:** 이주민 영유아의 주관적 건강인지율은 70.2%로, 한국국적 아동 87.0%보다 낮게 조사되었습니다.

- **높은 미충족 의료:** 필요한 치료를 받지 못한 비율은 19.3%로, 한국 국적 아동 2.4%보다 8배 이상 높았습니다.
- **늦게 병원에 가는 패턴:** 외래 이용은 상대적으로 낮고, 입원율 36.8%, 응급실 이용률 24.6%는 한국 국적 아동보다 훨씬 높아, 제때 진료를 받지 못하다가 상태가 악화된 뒤 병원을 찾는 흐름을 시사합니다.
- **예방접종 격차: 필수예방접종 완전접종률은 69.5%, 인플루엔자 접종률은 44.0%로 보고되어 정보 접근과 제도 안내의 격차가 드러났습니다.**
- **임산부·신생아 위험: 이주민 영유아 조산율은 12.1%로 한국 평균 9.9%보다 높았고, 미등록 이주민의 77.6%는 출산비나 신생아 치료비 때문에 심각한 어려움을 겪었다고 응답했습니다.**
- **비용·의사소통·신분 불안의 삼중 장벽:** 의료기관 이용의 어려움으로 의사소통 52.0%, 비용 부담 45.0%, 시간 부족 25.1%가 제시되었고, 미등록 이주민 가운데 34.7%는 단속의 두려움을 장애요인으로 꼽았습니다.

이 보고서는 특히 **영유아와 임산부는 '나중에 지원해도 되는 대상'이 아니라 가장 먼저 보호해야 할 공중보건 대상**임을 보여줍니다. **또한 미등록 이주 아동도 보건소 임시관리번호를 통해 민간 위탁의료기관에서 무료 예방접종이 가능하다는 점, 건강보험에 가입할 수 없는 산모와 아동을 위한 별도 의료지원, 통역 지원, 출산·소아진료가 가능한 지정병원 확보가 중요하다는 점을 시사합니다.**

6. 건강보험과 보건의료 접근에서 알아둘 점

최근 공공 보건의료 접근성을 높이기 위해 제도 개선이 이어지고 있습니다.
(2021년 기준 주요 개선사항)

- **유학생: 입국한 날부터 건강보험 지역가입 자격을 취득하며, 보험료를 일부 경감받습니다.**
- 외국인 노동자 (E-9): **사업자등록증이 없는 농축산어업에 종사하여 직장가입 대상이 아니더라도, 입국 즉시 지역가입이 가능해졌으며 보험료를 최대 50%까지 경감받을 수 있습니다.**
- 의무 가입: **외국인도 국내에 6개월 이상 거주하면 건강보험에 의무적으로 가입하도록 제도가 정비되었습니다.**

의료보장제도에서 일반인이 알아둘 실제 쟁점

- **6개월 요건의 부담:** 지역가입 의무화 자체는 보장 확대 취지가 있지만, 가입을 위한 국내 거주기간이 3개월에서 6개월로 길어지면서 초기 정착기에 의료 공백을 겪는 경우가 생길 수 있습니다.

- **보험료 부과의 체감 부담:** 영주권자와 결혼이민자를 제외한 많은 이주민은 실제 소득·재산으로 계산한 보험료보다 전년도 평균보험료가 더 높으면 그 높은 금액을 내야 해, '소득에 비해 보험료가 무겁다'고 느끼기 쉽습니다.
- **가족을 한 세대로 묶기 어려운 구조:** 세대원 범위가 배우자와 미성년 자녀 중심으로 좁아지고, 피부양자·세대원 등록 서류 요건도 강화되어 가족 단위 생활과 제도 적용 사이에 간극이 생깁니다.
- **체납의 파급효과: 보험료를 내지 못하면 급여 제한뿐 아니라 체류기간 연장에도 불이익이 생길 수 있어, 건강 문제와 체류 불안이 함께 커지는 악순환이 발생할 수 있습니다.**
- **의료급여의 좁은 문:** 일반적인 이주민은 의료급여 대상에서 대부분 제외되고, 결혼이민자 일부, 난민인정자, 사할린동포, 특별기여자 등 제한된 경우에만 적용됩니다.
- **미등록 이주민 지원사업의 한계:** 외국인 근로자 등 의료비 지원사업이 존재하지만 지원 대상이 좁고, 예산과 수행기관이 적어 실제 현장 접근성은 매우 낮다는 지적이 있습니다.

쉽게 말하면, **제도는 존재하지만 '누가, 언제, 얼마를 내고, 어디서 도움을 받을 수 있는가'에서 큰 차이와 공백이 생길 수 있다**는 점을 이해하는 것이 중요합니다.

7. 한국의 이주민 보건·차별금지 수준이 시사하는 점

이민자통합정책지수(MIPEX, 2020)에 따르면, 한국은 노동과 교육 영역에서는 비교적 개방적이나, **보건(Health) 분야는 52개국 중 33위(40점), 차별금지(Anti-discrimination) 분야는 41위(51점)로 상대적으로 취약**합니다. 이는 개인의 문제가 아니라 공중보건과 사회통합의 구조적인 한계를 보여줍니다.

> *"한국은 이민자를 일하게 하고 배우게 하지만, 아프지 않게 보호하는 데는 아직 부족하다." "이주민 보건 접근성은 시혜적 복지가 아니라 공중보건의 기본 조건이다." "보건소는 이주민을 '특수대상'이 아니라 지역사회 주민으로 포함시키는 최초의 공공 접점 기관이다."*

왜 '제도화'가 중요할까?

추가 자료에 따르면, 이주민 건강보호는 좋은 뜻만으로 오래 유지되기 어렵고, **입법·예산·행정·사업**이 함께 있어야 실제 제도가 됩니다. 즉, 법적 근거가 있고, 예산이 배정되고, 담당 조직과 인력이 있으며, 현장에서 작동하는 사업이 있어야 비로소 주민이 체감할 수 있습니다.

- 입법: **누가 어떤 지원을 받을 수 있는지의 최소 기준을 정합니다.**
- 예산: **통역, 예방접종, 의료비 지원, 방문사업을 실제로 움직이게 하는 재원입니다.**
- 행정: **보건소, 지자체, 병원, 학교, 복지기관을 연결하는 운영 체계입니다.**
- 사업: **주민이 실제로 만나는 검진, 상담, 예방접종, 의료비 지원, 연계 서비스입니다.**

다만 제도화는 자동으로 이루어지지 않습니다. 어떤 문제를 더 시급한 것으로 볼지, 누구에게 먼저 자원을 배분할지, 어떤 권리를 인정할지를 둘러싼 **정치적 선택과 힘의 관계**가 함께 작동합니다. 그래서 지역사회는 제도가 생긴 뒤에도 '최소한만 하는 제도'에 머물지 않도록 지속적으로 점검하고 보완해야 합니다.

8. 보건소가 꼭 알아야 할 점

- 이주민 보건은 선별적인 복지 혜택이 아니라 **지역 공중보건의 기본 인프라**입니다.
- 공중보건은 아픈 개인만 치료하는 것이 아니라, **지역 전체의 질병 예방과 건강증진을 다루는 영역입니다. 이런 점에서 보건소는 이주민 건강보장의 가장 현실적인 공공 접점입니다.**
- 지역보건은 주민, 보건전문가, 행정당국이 함께 지역의 건강문제를 해결하는 과정이므로, **이주민 건강도 '별도 사업'이 아니라 지역 건강계획 안에 포함되어야 합니다.**
- **다국어 정보 제공, 쉬운 안내문 비치, 의료통역 연계 체계를 구축해야 합니다.**
- 근무 시간 제약이 큰 이들을 위해 유관기관와 연계하여 **찾아가는 사업장·기숙사·학교 검진이나 주말·야간 접근성을 고민해야 합니다.**
- **감염병, 결핵, 예방접종, 임산부·영유아 보건, 정신건강, 만성질환, 응급·필수의료가 물흐르듯 연계되어야 합니다.**
- 특히 영유아 분야에서는 **예방접종, 영유아 건강검진, 산전·산후관리, 조산·신생아 치료 연계**를 한 묶음으로 보고 안내해야 합니다.
- 미등록 여부와 별개로, 전염병 차단이나 아동 보호 등 **조기개입이 반드시 필요한 공중보건 영역**이 존재함을 인식해야 합니다.
- 현장에서는 미등록 이주 아동도 **보건소 임시관리번호를 통해 민간 위탁의료기관에서 무료 예방접종이 가능할 수 있다**는 사실을 적극적으로 안내하고, **정보 부족 때문에 접종이 누락되지 않도록 해야 합니다.**
- 신분 확인이 어려운 국내 출생 아동이나 건강보험 공백기의 영유아는 보건소 단독으로 해결하기 어렵기 때문에, **지자체·병원· 이주민지원기관과 함께 신원**

확인 절차를 최대한 쉽게 설명하고 긴급의료·의료비 지원 연계를 조기에 시작하는 것이 중요합니다.

- **지역보건의료기관 자료가 보여주는 실무 과제:** 보건소는 모자보건, 영유아 예방접종, 만성질환 관리, 감염병 대응을 이미 수행하고 있으므로, **관내 이주민 고용 사업체, 의사회, 병원, 지원단체와 연결망을 만들면 훨씬 빠르게 사각지대를 줄일 수 있습니다.**
- 조례 제정, 예산 확보, 국가별 안내물 제작, 통역 인력 연계 같은 **'행정적 뒷받침'이 있어야 현장 사업이 일회성으로 끝나지 않습니다.**
- **[알아두면 좋은 행정 정보]** 공공보건포털(e보건소)을 통해 '결핵진단서(외국인)', '결핵 및 잠복결핵감염 검진결과서', '예방접종증명서' 등 비자 연장이나 생활에 필요한 각종 민원 문서 발급이 가능하므로, 이를 주민들에게 적극 안내하면 좋습니다.

9. 종교기관·지역민간단체가 꼭 알아야 할 점

- 교회와 지역 단체는 이주민을 단순한 선교나 봉사의 대상이 아니라, **'지역사회 건강 파트너'**로 접근해야 합니다.
- 병원 동행, 통역 연결, 보건소 예방접종 및 검진 정보 전달 등 실질적인 **다리 역할(Bridge)**이 매우 중요합니다.
- 특히 위기 임산부, 미접종 영유아, 조산·저체중아 치료가 필요한 가정, 고립된 청년이나 노동자를 조기에 발견하고 공적 상담 및 의료 제도와 연계해 주어야 합니다.
- **미등록 이주 아동도 예방접종 안내가 가능하다는 점, 보건소에서 임시관리번호를 통해 접종 경로를 안내받을 수 있다는 점을 지역사회가 알고 전달해 주면 큰 도움이 됩니다.**
- 지원을 할 때 **개인정보나 신분(미등록 여부)을 함부로 묻지 말고**, 두려움 때문에 의료 접근 자체를 포기하게 만드는 행동을 해서는 안 됩니다.
- **지역사회 내에서 이주민에 대한 혐오와 차별을 예방하는 교육의 장이 되어야 하며, 공적 제도와 연결하는 신뢰의 통로가 되어야 합니다.**

10. 주민이 알아두면 좋은 점

- **질병과 감염병은 국적을 가리지 않습니다. 이주민이 건강해야 우리 동네도 건강합니다.**
- **주변의 이주민 가정에 임산부나 영유아가 있다면, 예방접종 일정, 영유아 건강검진, 산전·산후관리, 결핵검진 같은 기본 정보를 먼저 알려주는 것만으로도 큰 도움이 됩니다.**
- **다문화가정이나 이주노동자가 주변에서 아파하거나 어려움을 겪고 있다면, 가까운 보건소나 이주민지원센터에 문의할 수 있도록 따뜻하게 안내해 주세요.**

11. 「이주아동 건강권 관련 토론 정리」가 특히 강조한 실무 메시지

[토론 자료가 보강해 준 핵심 메시지] 이주아동 건강권 관련 토론 정리 자료는, 이주민 건강문제를 단순한 복지나 선의의 지원이 아니라 **지역 공중보건 체계가 반드시 다뤄야 할 기본 과제**로 보아야 한다는 점을 다시 확인해 줍니다. 특히 미등록 여부와 상관없이 **감염병 대응, 예방접종, 임산부·영유아 건강, 조기 치료 연계**는 지역사회 전체의 안전과 직결되므로 가장 먼저 개입해야 할 영역임을 강조합니다.

- **보건소는 '첫 공공 접점'입니다:** 이주민이 제일 먼저 도움을 요청하거나 정보를 얻을 수 있는 기관으로서, 다국어 안내·쉬운 설명·통역 연계·예방접종 및 검진 안내를 체계화해야 합니다.
- **이주아동은 뒤로 미뤄도 되는 대상이 아닙니다:** 영유아 건강검진, 필수예방접종, 산전·산후관리, 조산·신생아 치료 연계는 공중보건상 우선순위가 높은 영역입니다.
- **미등록 상태에 대한 두려움이 의료회피를 만듭니다:** 신분 확인이나 단속 우려 때문에 병원과 보건소 이용을 포기하는 일이 없도록, 현장에서는 불필요하게 신분을 캐묻기보다 필요한 서비스 연결에 집중해야 합니다.
- **교회·종교기관·민간단체는 '다리 역할'이 중요합니다:** 병원 동행, 통역 연결, 예방접종 일정 안내, 위기 임산부·미접종 아동의 조기 발견 같은 실질적 연결 기능이 큰 힘이 됩니다.
- **차별과 정보격차도 건강장벽입니다:** 언어 문제만이 아니라 제도 설명 부족, 낯선 의료체계, 차별 경험이 함께 의료 접근을 막기 때문에, 쉬운 안내문과 신뢰 형성이 중요합니다.
- **지역사회 전체가 함께 움직여야 합니다:** 보건소 단독으로 해결하기 어려운 문제는 학교, 어린이집, 병원, 지자체, 이주민지원기관, 종교기관이 함께 연결망을 만들어야 사각지대를 줄일 수 있습니다.

[근거 자료 요약]

1. **법무부·찾기쉬운 생활법령정보:** 출입국관리법에 따른 외국인등록(90일 초과 체류 시 의무) 및 체류자격(비자) 분류 기준
2. **법무부 체류외국인 통계 (2025년 기준):** 장단기 체류외국인 규모(약 278만 명), 유학생, 취업자격, 결혼이민자, 영주권(F-5) 증가 추이 등 인구 구조 변화

3. **이민정책연구원 No. 2021-04 (장주영):** '이주민 건강과 건강권 제고' (건강취약성 요인, 의료 미이용 사유, 건강보험 개편 내용 및 정책 제언)
4. **이민정책연구원 No. 2025-11:** '이민정책 동향과 지역 정책적 현안' (취업형보다 정주형 이민 인구의 증가, 인구위기 대응을 위한 지역정부 역할 강화)
5. **2024 이주민 영유아 건강권 실태조사:** 미등록 아동 증가, 영유아 미충족 의료율 19.3%, 낮은 예방접종률, 조산율과 출산비 부담, 의사소통·비용·신분 불안에 따른 의료 장벽, 보건소 임시관리번호를 통한 예방접종 접근성 등 영유아 건강권의 핵심 쟁점
6. **「이주아동 건강권 관련 토론 정리」:** 이주아동 건강권을 공중보건의 핵심 과제로 보고, 보건소의 첫 공공 접점 역할, 미등록 여부와 무관한 조기 개입의 필요성, 교회·종교기관·민간단체의 연계 역할, 주민 대상 차별 예방과 정보 전달의 중요성을 정리한 자료
7. **「이주민과 의료보장제도」(김사강):** 외국인 건강보험 의무가입, 6개월 요건, 평균보험료 이상 부과 방식, 세대원 범위 축소, 체납 시 불이익, 의료급여 배제, 미등록 이주민 의료비 지원사업의 한계 등 의료보장제도의 쟁점
8. **「이주민 건강보호, 어떻게 제도화할 것인가?」(김창엽):** 이주민 건강보호는 입법·예산·행정·사업이 함께 작동해야 실효성이 생기며, 제도화는 정치적 선택과 권력관계 속에서 추진된다는 점
9. **「지역보건의료기관 현황과 이주민 건강보장」:** 공중보건과 지역보건의 관점에서 보건소가 이주민 건강보장의 최일선 공공 접점이며, 모자보건·감염병·만성질환 관리와 지역 연계가 핵심이라는 점
10. **이민자통합정책지수 (MIPEX 2020):** 한국의 보건(33위) 및 차별금지(41위) 지표와 사회통합 정책의 시사점
11. **질병관리청 e보건소 민원서비스:** 외국인 결핵진단서, 검진결과서, 예방접종증명서 등 행정 서비스 기준

※ 실제 체류자격 판단과 행정 적용은 출입국·법률·복지 기준에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 건강보험, 보건사업, 의료비 지원의 세부 대상과 요건은 시기와 제도 개편에 따라 달라질 수 있으므로 최신 안내를 함께 확인해야 합니다.